

accesibilidad mucho mayor que los opiáceos. Conviene, por tanto, cuestionarnos y reflexionar acerca de la cantidad de prescripciones realizadas fuera de ficha técnica y tener en presente a aquellos pacientes que presentan factores de riesgo para abusar de dichos fármacos.

Conflicto de intereses

No existe conflicto de interés.

Bibliografía recomendada

Abuse and Misuse of Pregabalin and Gabapentin: A Systematic Review Update. Evoy KE, Sacrameli S, Contreras J, Covvey JR, Peckham AM, Morrison MD. *Drugs*. 2021 Jan;81(1):125–156. doi: <https://doi.org/10.1007/s40265-020-01432-7>.

Gabapentinoid Benefit and Risk Stratification: Mechanisms Over Myth. McAnally H, Bonnet U, Kaye AD. 2020 Dec;9(2):441–452. doi: <https://doi.org/10.1007/s40122-020-00189-x>

Gabapentinoids: The rise of a new misuse epidemics?. Hofmann M, Besson M. *Psychiatry Res*. 2021 Nov;305:114193. doi: <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.114193>. Epub 2021 Aug 28.

How addictive are gabapentin and pregabalin? A systematic review. Bonnet U, Scherbaum N. *Eur Neuropsychopharmacol*. 2017 Dec;27(12):1185–1215. doi: <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2017.08.430>. Epub 2017 Oct 5.

On the addictive power of gabapentinoids: a mini review Bonnet U, Richter EL, Isbruch K, Scherbaum N. *Psychiatr Danub*. 2018 Jun;30(2):142–149. doi: [10.24869/psyd.2018.142](https://doi.org/10.24869/psyd.2018.142).

<https://doi.org/10.1016/j.psiq.2024.100642>

Relevancia de la coordinación entre Atención Primaria y Salud Mental en la prevención de la conducta suicida

Noemi Molina Pérez*, Jessica Pereira López, María Isabel Santana Ortiz, Francisco Acoidan Rodríguez Batista, Sara Reyes Molina, Paula Rivero Rodríguez, Marina Martínez Grimal

Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas, España

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: noemi988.mp@gmail.com (N.M. Pérez)

Introducción

El concepto de suicidio ha variado a lo largo de la historia, con diferentes consideraciones sociales, políticas, legales y sanitarias respecto al mismo, según el momento histórico; sin embargo, lo que ha permanecido, por desgracia, inmutable en el tiempo, el elevado coste de vidas humanas asociadas a este fenómeno.

El suicidio constituye un grave problema de salud pública, en el que los profesionales de atención primaria ocupan un puesto estratégico para la identificación y prevención del riesgo suicida; pues la adecuada prevención del suicidio requiere coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, desempeñando, el sistema sanitario, un papel importante a este respecto, de hecho, varios estudios han demostrado que la identificación temprana y el manejo eficaz del paciente con riesgo suicida, reduce la mortalidad por suicidio.

Objetivo

Conocer la importancia de la coordinación entre Atención Primaria y Salud Mental en la prevención de la conducta suicida.

Material y métodos

Revisar los resultados publicados de los programas de coordinación entre Atención Primaria y Salud Mental en la prevención de la conducta suicida, en España.

Conclusión

El papel de la atención primaria en la prevención de la conducta suicida queda patente con los datos aportados por diversos estudios que muestran que un alto porcentaje de la población acude a su médico de atención primaria los meses previos al suicidio. Según el estudio publicado por Stene-Larsen et al., aproximadamente el 80% de las personas fallecidas por suicidio, habían estado en contacto con los servicios de atención primaria en los doce meses antes del suicidio; es más, se ha observado que el 44% había contactado con su médico de atención primaria el mes antes del suicidio. Mientras que, el contacto con los profesionales de salud mental, durante el año antes al suicidio, fue de 31%. Por lo tanto, a raíz de los datos expuestos, abalados por otros estudios como el publicado por Luoma et al., en el que destacan el mayor contacto de los pacientes con los servicios de atención primaria, respecto a los servicios de salud mental, previo al intento de suicidio, se puede inferir que el diseño y aplicación de intervenciones que involucran a los profesionales de atención primaria, tienen el potencial de afectar las tasas de suicidio.

Conflicto de intereses

No existe conflicto de interés.

Bibliografía recomendada

Anseán, A. Suicidios. Manual de Prevención, Intervención y Postvención de la Conducta Suicida. 2a ed. Madrid: Fundación Salud Mental España, para la prevención de los trastornos mentales y el suicidio; 2014.

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Sanidad. Servicio de Salud del Principado de Asturias. Unidad Coordinación del Programa Marco de Salud Mental -SESP, Protocolo de detección y manejo de caso en personas con riesgo de suicidio. Asturias: Imprenta Goymar; 2018.

Jiménez-Sola E, Martínez-Alés G, Román-Mazuecos E, Sánchez-Castro P, Dios-Perrino C, Rodríguez-Vega B, Bravo-Ortiz M. Fe. Implementación de un programa de prevención del riesgo de suicidio en la Comunidad Autónoma de Madrid. La experiencia ARSUI. *Actas Esp Psiquiatr [Internet]* 2019 [Consultado 12 Feb 2021];47(6):229–35. Disponible en: <https://www.actaspsiquiatria.es/repositorio/21/122/ESP/21-122-ESP-229-35-624057.pdf>

Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. *Am J Psychiatry [Internet]* 2002 [Consultado 29 Abr 2021];159(6):909–16. Disponible en: <https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.159.6.909>

Navarro Gómez N. El abordaje del suicidio: revisión de las estrategias autonómicas para su intervención. *Rev. Esp Salud Pública [Internet]* 2020 (Consultado 29 Abr 2021); 94. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL94/C_ESPECIALES/RS94C_202005036es.pdf.

Reijas T, Ferrer E, González A, Iglesias F. Evaluación de un Programa de Intervención Intensiva en Conducta Suicida. *Actas Esp Psiquiatr [Internet]* 2013 [Consultado 12 Feb 2021]; 41(5):279–86. Disponible en: <https://actaspsiquiatria.es/repositorio/15/85/ESP/15-85-ESP-279-286-816367.pdf>

Stene-Larsen K, Reneflot A. Contact with primary and mental health care prior to suicide: A systematic review of the literature from 2000 to 2017. *Scand J Public Health [Internet]* 2019 [Consultado 29 Abr 2021]; 47(1):9–17. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1403494817746274>

Tejedor C, Díaz A, Faus G, Pérez V, Solà I. Resultados del programa de prevención de la conducta suicida. Distrito de la Dreta de l'Eixample de Barcelona. *Actas Esp Psiquiatr* [Internet] 2011 [Consultado 12 Feb 2021];39(5):280-7. Disponible en: <https://actaspsiquiatria.es/repositorio/13/73/ESP/13-73-ESP-280-287-385438.pdf>

<https://doi.org/10.1016/j.psiq.2024.100643>

Conductas suicidas: Tendencias y letalidad según el sexo

María del Carmen Pérez Gómez*, José Manuel Cerez Fernández, Almudena Paula Ceñal Sanchidrián, Guillermo Velarde Pedraza, Isabel Martín Talavera, Fuensanta Sánchez Muñoz

Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme, Sevilla, España

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: carperezgomez1994@gmail.com (M. del Carmen Pérez Gómez)

Introducción

La conducta suicida, en sus diferentes grados de severidad, desde la ideación suicida hasta el intento de suicidio, es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los Servicios de Urgencias. En este estudio se describen los tipos de intentos autolíticos realizados en función del sexo en el año 2021 en pacientes atendidos en el Área Sur de Sevilla.

Hipótesis

El objetivo de este estudio es comparar los métodos utilizados para llevar a cabo gestos o intentos autolíticos en función del sexo en este último año, en base a datos recogidos en el último año en nuestro centro.

Método

Recogida de datos de tentativas autolíticas de los años 2019, 2020 y 2021 que han sido atendidos por Psiquiatría en el Servicio de Urgencias del Hospital Valme, referente de la población del Área Sur de Sevilla. Se extraen los tipos de intentos autolíticos registrados durante el año 2021 teniendo en cuenta la variable sexo.

Resultados

Se realiza un registro total de 1621 gestos o intentos autolíticos; 535 durante el año 2021, siendo estos datos con los que vamos a trabajar en este estudio descriptivo. Se agrupan por la variable sexo, obteniendo que 340 fueron mujeres y 195 hombres. También se agrupan los pacientes en función del tipo de intento autolítico recogiendo un total de 439 Ingestas Medicamentosas Voluntarias (IMV), 53 cortes autolesivos o venoclisis, 21 intentos mediante ahorcamiento, 17 precipitaciones, 1 mediante inhalación de CO₂, ninguno con armas de fuego y 4 mediante otros métodos diferentes a los anteriores.

A continuación se agrupan los tipos de intentos autolíticos en función de la variable sexo; obteniendo que de las 340 mujeres 290 realizan intento mediante IMV, 34 mediante cortes, 5 mediante ahorcamiento, 9 precipitaciones, 2 con otros métodos no descritos y ningún registro de inhalación de CO₂ ni relacionado con armas de fuego. Del total de 195 hombres, 149 realizan intento mediante IMV, 19 mediante cortes, 16 mediante ahorcamiento, 8 precipitaciones, 1 con inhalación de CO₂, 2 con otros métodos no descritos y ninguno con armas de fuego.

Discusión

Durante el último año los intentos autolíticos han sido notablemente más frecuentes en mujeres, aunque existe una limitación importante en este estudio al no tener datos sobre los suicidios consumados por ambos sexos. En ambos, el método más frecuente para realizar intentos autolíticos es la ingesta medicamentosa voluntaria, aunque en mujeres es más acentuado siendo un 85,3% del total, comparado con el 76,4% en hombres; lo que indica que los hombres utilizan otros métodos diferentes con mayor frecuencia. Entre varones es más frecuente la elección de métodos considerados de alta letalidad como el ahorcamiento y la precipitación.

Conclusiones

En el último año la tendencia en conductas autolíticas ha resultado ser más frecuente en paciente mujeres que en varones, sin embargo los métodos elegidos para llevar a cabo el suicidio son de mayor letalidad en el sexo masculino.

Conflicto de intereses

No existe conflicto de interés.

Bibliografía recomendada

Base de datos intentos autolíticos. Área Sur de Sevilla. Hospital Valme.

SEDUP. Manual de urgencias en psiquiatría. 1ª Edición. 2018. España.

<https://doi.org/10.1016/j.psiq.2024.100644>

Cómo el tratamiento Depot puede ser beneficioso para la prevención de la conducta suicida en los pacientes con trastornos mental grave en una Unidad de Salud Mental de adultos

Sofía Belló Pérez*, Marta Villodres Moreno, Lluch Esparza de la Guía, Pablo De Fez Febré, Patricia Latorre Forcén, Miguel Pascual Oliver, Olalla Frade Pedrosa

Servicio de Psiquiatría, Hospital Obispo Polanco, Teruel, España

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: sofia_bp_93@hotmail.com (S.B. Pérez)

Introducción

El suicidio supone un grave problema de salud pública que causa la muerte de 11 personas de media al día en nuestro país. Tanto es así que en 2020 el número de suicidios consumados en España fue 3941. Un importante factor de riesgo para la conducta suicida es padecer un trastorno mental, en especial si este es grave. Es por ello que en múltiples ocasiones la prevención del suicidio consumado y/o la conducta suicida va a ir de la mano de la estabilización clínica de nuestros pacientes. Una forma de asegurar la adherencia terapéutica para ello es la administración del tratamiento en formato Depot.

Hipótesis

Los pacientes diagnosticados con trastorno mental grave según CIE-10 de nuestra unidad de salud mental tratados con Paliperidona Depot a lo largo de su curso clínico han demostrado menor porcentaje de conducta suicida que al inicio de su enfermedad.

Nuestro objetivo es obtener datos estadísticos de ellos para tener en cuenta en próximas intervenciones terapéuticas.